[Intro-Musik]

Ben: [neugierig] Nora, was ist das für ein Zettel? Du hältst den fest, als wär's ein Lottoschein.

Nora: [lacht] Fast. Das ist meine Sammlung. Alles, was ich in den letzten Wochen auf Station über Thrombose gehört hab.

Ben: Und?

Nora: Die Hälfte davon stimmt nicht.

Ben: [lacht] Okay, jetzt bin ich gespannt.

Nora: [warm] Willkommen zurück bei Pflege-WG, Folge vier unserer Prophylaxen-Reihe! Heute: Thromboseprophylaxe. Aber nicht als Vortrag.

Ben: Sondern?

Nora: Als Spiel. Ich lese dir einen Satz vor, du sagst: Mythos oder Fakt. Für jede richtige Antwort gibt's einen Punkt.

Ben: Und wenn ich verliere?

Nora: Dann ziehst du in der nächsten Folge die Kompressionsstrümpfe an.

Ben: [seufzt] Ich hab ja keine Wahl. Los.

Nora: Satz Nummer eins. „Thrombose? Das kriegen doch nur alte Leute."

Ben: Mythos. Ganz klar.

Nora: Begründung?

Ben: Äh... [kurze Pause] weil... auch junge Leute im Bett liegen?

Nora: [lacht] Das ist ein Anfang. Merk dir dafür die Virchow-Trias. Drei Dinge, die eine Thrombose begünstigen. Erstens: Das Blut fließt langsamer, zum Beispiel weil jemand im Bett liegt und sich kaum bewegt.

Ben: Okay.

Nora: Zweitens: Die Gefäßwand ist geschädigt, zum Beispiel durch eine Operation oder eine Entzündung. Und drittens: Die Gerinnung ist verändert, etwa durch bestimmte Medikamente oder in der Schwangerschaft.

Ben: Also kann das genauso den Fünfundzwanzigjährigen nach der Knie-OP treffen.

Nora: Genau. Und wenn sich so ein Gerinnsel löst, kann es in die Lunge wandern.

Ben: Lungenembolie.

Nora: Genau deshalb machen wir das ganze Theater. Punkt für dich.

Ben: [zufrieden] Eins zu null.

Nora: Satz Nummer zwei. „Thrombosestrümpfe zieht man morgens an und abends wieder aus. Nachts braucht die keiner."

Ben: Hm... [überlegt] Klingt logisch. Fakt?

Nora: [lacht] Leider Mythos.

Ben: Nein!

Nora: Die medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfe, kurz MTS, bleiben rund um die Uhr dran. Auch nachts.

Ben: Die ganze Zeit?

Nora: Fast. Zweimal am Tag zieht man sie kurz aus, für die Körperpflege und um die Haut anzuschauen. Und kleiner Tipp: Direkt davor nicht eincremen.

Ben: Warum nicht?

Nora: Probier mal, einen engen Strumpf über frisch eingecremte Beine zu ziehen.

Ben: [lacht] Okay, verstanden. Eins zu eins.

Nora: Satz Nummer drei. „Strumpfgröße? Egal. Hauptsache, er sitzt schön eng."

Ben: Mythos! Den weiß ich. Man misst vorher aus.

Nora: Was denn genau?

Ben: Beinlänge... [kurze Pause] Wadenumfang... und Oberschenkel?

Nora: Perfekt. Und jetzt die Bonusfrage: Wann musst du neu messen?

Ben: Wenn der Patient abgenommen hat?

Nora: Zum Beispiel. Ganz typisch ist es bei Diuretika. Der Patient verliert Wasser, die Beine werden schmaler...

Ben: ...und der Strumpf passt plötzlich nicht mehr.

Nora: Genau. Deshalb wird dann vor jedem Strumpfwechsel neu gemessen. Zwei Punkte für dich.

Ben: [stolz] Drei zu eins. Ich spür schon den Sieg.

Nora: Nicht so schnell. Satz Nummer vier. „Der Patient hat dicke Ödeme an den Beinen? Dann braucht er die Strümpfe erst recht."

Ben: [zögert] Puh... Ödeme, Druck von außen... das klingt eigentlich sinnvoll.

Nora: Klingt sinnvoll, ist aber ein Mythos. Ausgeprägte Ödeme gehören zu den Kontraindikationen.

Ben: Echt jetzt?

Nora: Ja. Genauso wie eine arterielle Verschlusskrankheit, eine Polyneuropathie oder eine Allergie gegen das Strumpfmaterial. In solchen Fällen zieht man nicht einfach Strümpfe an, sondern spricht mit dem Arzt.

Ben: Okay, das schreib ich mir auf. Drei zu zwei.

Nora: Und falls die Standardgrößen gar nicht passen?

Ben: Dann... [kurze Pause] Verband?

Nora: Genau, ein Kompressionsverband, zum Beispiel nach Pütter. Mit Kurzzugbinden, und der Druck nimmt von unten nach oben ab.

Ben: Also unten am Fuß fester, oben lockerer.

Nora: Richtig. Nach einer halben Stunde kontrollierst du, ob er zu fest sitzt. Schmerzen oder blaue Zehen sind ein Alarmsignal. Und neu gewickelt wird mindestens zweimal am Tag.

Ben: Notiert.

Nora: Jetzt wird's heikel. Satz Nummer fünf. „Bei der Heparinspritze immer erst aspirieren und die Luftblase aus der Fertigspritze drücken."

Ben: [lacht nervös] Das hab ich in meinem ersten Einsatz genau so gemacht.

Nora: [lacht] Ich weiß. Deshalb steht's auf der Liste.

Ben: Also... ich sag Fakt. Sonst hätte ich's ja nicht so gemacht.

Nora: [lacht] Doppelter Mythos.

Ben: [seufzt] Mist.

Nora: Erstens: Nicht aspirieren. Das verursacht kleine Verletzungen im Gewebe, und dann gibt's blaue Flecken.

Ben: Und die Luftblase?

Nora: Bleibt drin. Sie ist mit Absicht in der Fertigspritze, damit am Ende wirklich die ganze Dosis im Gewebe landet.

Ben: Das ist echt ein Klassiker für die Prüfung, oder?

Nora: Absolut. Gespritzt wird übrigens subkutan, meist in die seitliche Bauchdecke unterhalb vom Nabel oder außen in den Oberschenkel.

Ben: Okay, dein Punkt. Drei zu drei.

Nora: [lacht] Fair. Satz Nummer sechs, direkt hinterher. „Nach der Spritze die Stelle schön verreiben, dann verteilt sich das Heparin besser."

Ben: [schnell] Mythos! Gleicher Grund: kleine Verletzungen, blaue Flecken.

Nora: Richtig! Und welche Nebenwirkungen musst du beim Heparin im Blick haben?

Ben: Blutungen.

Nora: Und?

Ben: [überlegt] Irgendwas mit den Thrombozyten...

Nora: Genau, die Thrombozyten können abfallen. Dazu kommen allergische Reaktionen und Rötungen an der Einstichstelle.

Ben: Gibt's dafür einen halben Punkt extra?

Nora: [lacht] Na gut. Viereinhalb zu drei. Letzter Satz. „Wer Heparin kriegt, muss sich nicht mehr bewegen. Das Medikament macht ja die Arbeit."

Ben: Mythos. Bewegung bleibt die Basis.

Nora: Warum?

Ben: Wegen der... [kurze Pause] Wadenmuskelpumpe! Wenn die Wade arbeitet, drückt sie das Blut nach oben.

Nora: [beeindruckt] Wow. Also: mobilisieren, so früh wie möglich, Fußgymnastik im Bett und genug trinken. Die Strümpfe und das Heparin kommen dazu, aber sie ersetzen die Bewegung nicht.

Ben: Fünfeinhalb zu drei. [lacht] Wer zieht jetzt die Strümpfe an?

Nora: [seufzt] Wir reden später drüber. Erst kommt noch ein Fall, und der zählt doppelt.

Ben: [lacht] Natürlich zählt der doppelt.

Nora: Herr K., zweiter Tag nach einer Hüft-OP. Er trägt Strümpfe und bekommt Heparin. Du

ziehst ihm morgens die Strümpfe aus, für die Körperpflege, und merkst: Das linke Bein ist deutlich dicker als das rechte, warm und tut ihm an der Wade weh.

Ben: [ernst] Okay... das klingt nach einer Thrombose.

Nora: Was machst du?

Ben: Als Erstes: nicht massieren, nichts reiben. Er bleibt erst mal liegen, ich mobilisiere ihn nicht. Und ich informiere sofort den Arzt.

Nora: Und dann?

Ben: Ich dokumentiere, was ich gesehen habe, und warte auf die ärztliche Anordnung, bevor die Strümpfe wieder drankommen.

Nora: [ruhig] Genau richtig. Und genau dafür ziehst du die Strümpfe zweimal am Tag aus: um sowas zu sehen.

Ben: Das heißt, ich hab gewonnen.

Nora: [lacht] Ja, du hast gewonnen. Ich zieh nächste Woche die Strümpfe an.

Ben: Ich mach ein Foto.

Nora: Untersteh dich. Fassen wir kurz zusammen.

Ben: Virchow-Trias: Blut fließt langsamer, Gefäßwand geschädigt, Gerinnung verändert.

Nora: MTS: vorher genau messen, rund um die Uhr tragen, Kontraindikationen beachten. Und wenn keine Standardgröße passt, ein Kompressionsverband nach Pütter.

Ben: Heparin: nicht aspirieren, Luftblase drin lassen, nicht verreiben.

Nora: Und Bewegung bleibt die Basis. Immer.

Ben: So, das war's für heute von uns.

Nora: Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, [lacht] Respekt, ehrlich.

Ben: Und falls euch das was gebracht hat für die Ausbildung, oder ihr einfach Lust auf mehr habt—

Nora: —dann abonniert uns gern, kostet nix und ihr verpasst keine Folge mehr.

Ben: Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, oder was unklar war, oder ihr wollt einfach mal meckern, dass ich wieder zu viel gequatscht hab—

Nora: [lacht] Was regelmäßig vorkommt—

Ben: —dann schreibt's einfach in die Kommentare, wir lesen wirklich alles.

Nora: Stimmt, und manchmal wird aus euren Fragen sogar die nächste Folge, also scheut euch nicht.

Ben: Genau. Bis zum nächsten Mal, bei Pflege-WG.

Nora: Macht's gut, tschüss zusammen!

[Outro-Musik]